BULLETIN HEBDOMADAIRE · CENTRE DE CARDIOLOGIE DE RODEZ

PAUSE CARDIO ❤

Nouveautés de la semaine du 8 novembre 2026

6 nouveautés cette semaine, dont 1 susceptible de changer votre pratique.

PRÉVENTION **Changement de pratique** Essai randomisé · Lp(a)HORIZON

Pelacarsen and Cardiovascular Outcomes in Patients with High Lipoprotein(a)

NEJM · 7 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Cet essai de phase 3 en double insu a comparé le pelacarsen, oligonucléotide antisens qui bloque la production de lipoprotéine(a), à un placebo chez environ 8 300 patients en prévention secondaire dont la Lp(a) atteignait au moins 70 mg/dL. Le pelacarsen a abaissé la Lp(a) de 77,7 % à 12 mois par rapport au placebo, mais, après un suivi médian de 4,7 ans, le critère principal composite (décès cardiovasculaire, infarctus non fatal, AVC non fatal, revascularisation coronaire urgente) est survenu chez 12,3 % des patients sous pelacarsen contre 12,1 % sous placebo (HR 1,02 ; IC95 % 0,90–1,15). Aucune composante du critère ni aucun sous-groupe, y compris les patients dont la Lp(a) atteignait au moins 90 mg/dL, n'a montré de bénéfice, et le développement du pelacarsen dans la maladie athéroscléreuse est arrêté.

> **En pratique :** ce premier essai de morbi-mortalité d'un traitement abaissant la Lp(a) est négatif, malgré une baisse du taux de plus des trois quarts. Chez le patient en prévention secondaire dont le LDL-cholestérol et la pression artérielle sont déjà bien contrôlés, abaisser la Lp(a) avec le pelacarsen n'apporte aucun bénéfice démontré, et le développement de la molécule dans cette indication est arrêté. Le dosage de la Lp(a) reste recommandé une fois dans la vie : une valeur élevée est un facteur aggravant qui incite à corriger plus strictement les facteurs de risque modifiables, mais aucun traitement spécifique n'a prouvé son bénéfice à ce jour. Les ARN interférents et le muvalaplin, en cours d'évaluation dans des essais de morbi-mortalité, diront si une autre molécule, une baisse plus profonde ou une population différente donnent un autre résultat.

Article original · Analyse TCTMD

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL **À connaître** Suivi à long terme · COURAGE

Percutaneous Coronary Intervention and Long-Term Outcomes in Stable Coronary Artery Disease: Extended Follow-Up of the COURAGE Randomized Trial

JAMA · 7 novembre 2026 · Suivi à long terme · COURAGE

L'essai COURAGE, publié en 2007, n'avait pas montré de réduction des décès ou des infarctus quand une angioplastie d'emblée était ajoutée au traitement médical optimal dans la coronaropathie stable. Cette lettre de recherche rapporte le suivi prolongé de 959 participants, des vétérans américains pris en charge dans 15 hôpitaux, sur une médiane de 15 ans et jusqu'à 25 ans. L'incidence cumulée des décès ou des infarctus à 25 ans a été de 93,3 % avec l'angioplastie d'emblée, contre 91,0 % avec le traitement médical seul, sans différence significative ; les décès et les infarctus pris séparément ne différaient pas non plus. Au cours du suivi, plus de la moitié des patients de chaque groupe ont eu une revascularisation : une première dans le groupe médical, une nouvelle dans le groupe angioplastie.

> **En pratique :** dans la coronaropathie stable, l'angioplastie d'emblée ajoutée au traitement médical optimal n'a réduit ni les décès ni les infarctus, même après un suivi médian de 15 ans et jusqu'à 25 ans ; un suivi plus long ne fait pas apparaître de bénéfice que l'essai initial n'avait pas montré. Pour les investigateurs, ce résultat ne plaide pas pour une stratégie systématique d'angioplastie élective d'emblée dans le but de réduire les décès ou les infarctus à long terme ; il ne porte pas sur le contrôle des symptômes. Il repose sur un sous-échantillon de vétérans à risque plus élevé, traités pour l'essentiel par stents nus, et ne renseigne pas sur l'angioplastie avec les stents actuels.

Article original

PRÉVENTION À connaître Essai randomisé factoriel · Ez-PAVE

Statin-ezetimibe combination therapy vs statin monotherapy in atherosclerotic cardiovascular disease: a prespecified secondary analysis of the randomized Ez-PAVE trial

Circulation · 7 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Dans l'essai Ez-PAVE, 3 048 patients atteints d'une maladie athéroscléreuse ont été randomisés deux fois, selon un plan factoriel : entre une cible de LDL-C inférieure à 55 mg/dL et une cible inférieure à 70 mg/dL, puis entre une association rosuvastatine plus ézétimibe d'emblée et une statine seule. Le traitement était ensuite ajusté à chaque visite pour atteindre la cible attribuée. Cette analyse secondaire préspécifiée porte sur la seconde randomisation. À 3 ans, 8,5 % des patients sous association d'emblée avaient présenté un décès cardiovasculaire, un infarctus, un AVC, une revascularisation ou une hospitalisation pour angor instable, contre 7,9 % sous statine seule, sans différence significative. L'association a abaissé davantage le LDL-C, mais, selon la cible, près d'un quart à plus d'un tiers des patients sous statine seule ont reçu de l'ézétimibe en cours de suivi pour atteindre la cible.

> **En pratique :** quand le LDL-C est surveillé et le traitement ajusté jusqu'à la cible, commencer par une statine seule et ajouter l'ézétimibe au besoin n'a pas conduit, à 3 ans, à davantage d'événements que l'association d'emblée ; pour les investigateurs, c'est l'atteinte de la cible qui compte, plus que le schéma de départ. L'association d'emblée a abaissé davantage le LDL-C ; selon les investigateurs, elle l'abaisse aussi plus vite et garde son intérêt quand le LDL-C initial est loin de la cible. La comparaison n'était pas dimensionnée pour les événements cliniques : elle ne permet pas d'exclure une différence modeste entre les deux stratégies.

Article original · Analyse HCPLive

PRÉVENTION À connaître Essai randomisé · OPTIMAL-DIABETES

Intensive blood pressure therapy did not cut cardiovascular events in adults with diabetes (OPTIMAL-DIABETES)

NEJM · 7 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Cet essai randomisé en ouvert, conduit dans 33 centres au Brésil, a comparé une cible de pression artérielle systolique inférieure à 120 mmHg et une cible inférieure à 140 mmHg chez 9 476 adultes de 50 ans et plus ayant un diabète de type 2 et un risque cardiovasculaire élevé. Après un suivi médian de 4 ans, le critère composite associant décès cardiovasculaire, AVC, infarctus et hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou angor instable est survenu chez 6,0 % des patients du groupe intensif contre 6,7 % du groupe standard, une différence qui n'est pas statistiquement significative. Les événements rénaux ont été plus fréquents sous cible intensive (5,7 % contre 3,7 %), surtout des baisses de la fonction rénale.

> **En pratique :** chez le diabétique de type 2 à risque cardiovasculaire élevé, viser une pression systolique inférieure à 120 mmHg n'a pas réduit de façon significative les événements cardiovasculaires majeurs par rapport à la cible inférieure à 140 mmHg, alors que les événements rénaux ont été plus fréquents. Ce résultat neutre est à mettre en regard de BPROAD, positif dans une autre population de diabétiques de type 2 : la cible tensionnelle idéale chez le diabétique de type 2 reste incertaine. Les investigateurs plaident pour une cible fixée patient par patient, en tenant compte du bénéfice attendu, de la fonction rénale, de la lourdeur du traitement et des préférences du patient, plutôt que pour une cible inférieure à 120 mmHg appliquée à tous.

Article original

PRÉVENTION À connaître Essai randomisé · OPTIMAL-STROKE

Intensive Blood-Pressure Control in Patients with Previous Ischemic Stroke

NEJM · 7 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Cet essai randomisé, conduit dans 30 centres au Brésil, a comparé une cible de pression artérielle systolique inférieure à 120 mmHg et une cible inférieure à 140 mmHg chez 4 368 patients ayant un antécédent d'AVC ischémique ou d'accident ischémique transitoire. La randomisation a eu lieu en médiane un an après l'événement. Après un suivi moyen de 3,9 ans, le critère composite associant décès cardiovasculaire, infarctus, AVC et hospitalisation pour angor instable ou insuffisance cardiaque est survenu chez 10,9 % des patients du groupe intensif contre 13,5 % du groupe standard (HR 0,79 ; IC95 % 0,67–0,94). Les événements rénaux ont été plus fréquents sous cible intensive (3,9 % contre 2,2 %), surtout des baisses durables du débit de filtration glomérulaire.

> **En pratique :** après un AVC ischémique, viser une pression systolique nettement plus basse que 140 mmHg a réduit les événements cardiovasculaires majeurs, au prix d'un surcroît d'événements rénaux, surtout des baisses du DFGe. Selon le discutant de la présentation, pour 1 000 patients traités pendant près de 4 ans, environ 26 événements cardiovasculaires sont évités et 17 événements rénaux surviennent en plus. La cible de 120 mmHg est difficile à atteindre, même dans un essai : la pression réellement obtenue était d'environ 122 mmHg, avec trois antihypertenseurs en moyenne. Des commentateurs de la présentation ont jugé plus réaliste une cible de 125 à 130 mmHg, qui rejoint la cible inférieure à 130/80 mmHg de la recommandation AHA/ACC 2025. Ils ont aussi plaidé pour une surveillance au moins annuelle de la fonction rénale sous traitement intensifié.

Article original · Analyse TCTMD

PRÉVENTION À connaître Essai randomisé · ZEUS

Interleukin-6 Inhibition with Ziltivekimab for Atherosclerotic Disease

NEJM · 7 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Cet essai de phase 3 en double insu a comparé le ziltivekimab, anticorps monoclonal dirigé contre l'interleukine-6 (IL-6), à un placebo chez 6 376 patients qui cumulaient maladie athéroscléreuse, maladie rénale chronique et inflammation résiduelle (CRP ultrasensible d'au moins 2 mg/L). Après un suivi médian de 33 mois, le critère principal (décès cardiovasculaire, infarctus non fatal, AVC non fatal) est survenu chez 17,6 % des patients sous ziltivekimab contre 17,7 % sous placebo (HR 0,99 ; IC95 % 0,88–1,11), alors que la CRP ultrasensible et l'IL-6 libre avaient nettement baissé. Les infections graves ont été un peu plus fréquentes sous traitement actif (20,4 % contre 17,9 %).

> **En pratique :** chez le patient athéroscléreux qui cumule maladie rénale chronique et inflammation résiduelle, bloquer l'IL-6 par le ziltivekimab n'apporte aucun bénéfice démontré sur les événements cardiovasculaires et expose à un peu plus d'infections graves. Rien ne change dans les prescriptions : la correction des facteurs de risque classiques reste la base. Ce résultat ne ferme pas la piste anti-inflammatoire, puisque le canakinumab et la colchicine à faible dose ont réduit les événements dans des essais antérieurs, mais il ne la confirme pas pour l'inhibition de l'IL-6 dans cette population. L'essai ARTEMIS, après infarctus, dira si l'inhibition de l'IL-6 garde un intérêt à un stade plus précoce.

Article original · Analyse TCTMD

Fiches rédigées à l'aide de l'IA — résumés à valider par le lecteur avant toute application clinique, se reporter aux articles originaux.